

Transição Demográfica e Oftalmologia na Saúde Suplementar: Pressão de Demanda, Custos e Reorganização de um Mercado de R\$ 10 Bilhões

Edição 006/2026 | 31 de maio de 2026 | Publicado

1. Contexto: A Demografia e o Mercado Oftalmológico

A oftalmologia no Brasil concentra três condições estruturais que operam na mesma direção, formando um mercado que movimenta entre R\$ 8 e R\$ 10 bilhões anuais [1]. Primeiro, o envelhecimento da população converte a prevalência de doenças oculares em volume assistencial de forma automática. Em 2022, a população acima de 65 anos representava 10,9% dos brasileiros, com projeção de atingir 37,8% em 2070. Consequentemente, a prevalência de catarata supera 85% nos pacientes acima de 80 anos, enquanto a degeneração macular relacionada à idade acomete mais de 30% dessa faixa [1].

Em 2024, foram realizadas 1,8 milhão de cirurgias de catarata no país. A saúde suplementar, com 52,2 milhões de beneficiários, realizou 664.861 dessas cirurgias, apresentando uma taxa de 1.276,79 procedimentos por 100 mil beneficiários — um volume 73,4% superior à taxa da rede pública exclusiva (SUS) [1]. A disparidade de acesso é agravada pela distribuição desigual dos 16.784 especialistas ativos, com razões extremas entre o Distrito Federal (19,18 por 100 mil) e o Amazonas (3,60 por 100 mil) [1].

2. Síntese: Fragmentação e Gap Regulatório

O mercado oftalmológico privado é altamente fragmentado. Embora existam grupos consolidados, a maior parte da oferta está distribuída em clínicas independentes sem escala operacional consolidada e sem poder de negociação [1].

A cobertura obrigatória definida pelo Rol da ANS cobre o procedimento básico (facoemulsificação com lente intraocular monofocal), mas exclui procedimentos de maior valor tecnológico (como laser de femtossegundo e lentes multifocais/tóricas). Esse gap regulatório estrutura um mercado de desembolso direto permanente, onde o ticket para cirurgias com tecnologia superior varia entre R\$ 3 mil e R\$ 20 mil por olho, operando fora da tabela das operadoras [1].

3. Implicações

As três forças — transição demográfica, gap regulatório e fragmentação da oferta — reforçam-se mutuamente [1]:

- **Pressão de Demanda e Custo:** A demografia expande a base de pacientes continuamente. Doenças como catarata, glaucoma e retinopatia diabética têm prevalência indexada à idade e tratamento exclusivamente clínico ou cirúrgico, pressionando as despesas assistenciais projetadas (estimadas em R\$ 383,5 bilhões para 2030).
- **Mercado de Desembolso Direto:** A limitação do Rol ANS preserva um canal de receita robusto para as clínicas através de tecnologias não cobertas, criando lógicas econômicas distintas dentro do mesmo evento cirúrgico.
- **Espaço para Consolidação:** A fragmentação do mercado mantém aberto o espaço para consolidação por capital privado e para o reposicionamento estratégico de clínicas independentes.

Região	Taxa SUS (por 100 mil hab.)	Taxa Planos (por 100 mil hab.)	Diferença Planos vs SUS
Brasil	736,3	1.276,8	+73,4%
Norte	372,0	957,4	+157,0%
Nordeste	745,1	1.277,7	+71,0%
Sudeste	892,4	1.237,3	+39,0%
Sul	729,1	1.735,9	+138,0%
Centro-Oeste	485,6	908,1	+87,0%

Fonte: Tabela reproduzida dos dados do estudo primário [1].

4. Recomendações

Com base na análise do mercado oftalmológico [1], recomenda-se:

- Para Operadoras: Estruturar modelos de remuneração que antecipem o crescimento exponencial do volume cirúrgico impulsionado pelo envelhecimento, superando o modelo fee-for-service.
- Para Prestadores (Clínicas e Hospitais): Otimizar a eficiência operacional e a coordenação do cuidado, aproveitando o espaço de consolidação e as oportunidades geradas pelo mercado de desembolso direto em tecnologias não cobertas pelo Rol.

5. Referências

[1] Estudo Base: Oftalmologia no Brasil: o mercado de R\$10 bilhões que o envelhecimento vai reorganizar. Evodux Intelligence, 31 de maio de 2026. (Análise primária que fundamenta integralmente os dados, valores e conclusões desta edição do Compass™).